PERÚ Ministerio de Salud

REFORMA es más SALUD

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

ORIENTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DEL AGENTE COMUNITARIO EN SALUD



DOCUMENTO TÉCNICO

RESOLUCION MINISTERIAL N° 411 - 2014/MINSA

PERÚ | Ministerio de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

DOCUMENTO TÉCNICO:

ORIENTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

2014

Catalogación hecha por la Biblioteca Central del Ministerio de Salud:

Orientaciones para el fortalecimiento de la labor del agente comunitario de salud: Documento técnico / Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. -- Lima: Ministerio de Salud; 2014. 47 p.; ilus.

PROMOCIÓN DE LA SALUD / AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD / PERSONAL DE SALUD / EDUCADORES EN SALUD / CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD / SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA, Organización & Administración.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2014-18921

"Orientaciones para el fortalecimiento de la labor del Agente Comunitario de Salud": Documento Técnico

Responsable del Documento Técnico:
Lic. Ofelia María de Jesús Alencastre Mamani
Dirección de Participación Comunitaria en Salud
Dirección General de Promoción de la Salud DGPS

Revisión de contenidos:

Dr. Luis Robles Guerrero	Secretaría General del MINSA
Lic. Susy Flores Saire	Dirección de Participación Comunitaria en Salud. DGPS.
Ps. Maria Elena Morante Maco	Dirección de Promoción de Vida Sana. DGPS.
Lic. Néstor Rejas Tataje	Dirección de Educación para la Salud. DGPS.
Med. Olga Patricia Polo Ubillus	Dirección General de Salud de las Personas
Méd. César Bueno Cuadra	Dirección General de Epidemiología
Lic. Lily Cortez Yacila	Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos
Lic. Patricia Vásquez Reyes	Oficina General de Estadística e Informática
Méd. Williams Americo Sanchez Martinez	Oficina General de Defensa Nacional
Abog. Percy Zavala Jaramillo	Defensoría de la Salud y Trasparencia
Lic. Silvia Yopla Sosa	Oficina General de Comunicaciones

© MINSA, 2014

Carátula: Roberto Gutiérrez Pérez
Ministerio de Salud
Av. Salaverry N° 801, Lima 11-Perú
Telf.: (51-1) 315-6600
http://www.minsa.gob.pe
webmaster@minsa.gob.pe

1ra. Edición, noviembre 2014
Tiraje: 1,000 unidades
Imprenta: Richard Huamani Enciso **Dirección:** Jr. Succha 271 Breña
Diagramación y Diseño: AGS Diseños & Impresiones **E-mail:** rhd20009@hotmail.com

Versión digital disponible: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/6104.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgps

Agradecimientos: Diresa Huancavelica, Diresa Cusco, Diresa Apurímac, Diresa Ucayali, Diresa Huánuco, Diresa Lima Región, Geresa La Libertad, Diresa Callao, Disa II - Lima Sur, Disa IV - Lima Este. Plan International – Perú, CARE – Perú, Caritas del Perú, Adra-Perú, Asociación Kusiwarma, Medicus Mundi Navarra - Delegación Perú, World Vision International, Asociación Benéfica Prisma, Management Sciences for Health (MSH – Peru), CESAL – Perú, Movimiento Manuela Ramos, Asociación de Defensa y Desarrollo en las Comunidades Andinas del Perú (ADECAP), INMED ANDES, Cruz Roja Peruana, Future Generations, Pathfinder International, UNICEF – Perú, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y agentes comunitarios de salud del país.

Un agradecimiento especial a las y los Agentes Comunitarios de Salud, quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen a la mejora de la salud de las comunidades del país.

MINISTERIO DE SALUD

No. 411-2014/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 3 de JUNIO del 2014

Visto, el Expediente N° 13-105787-002, que contiene los Informes N°s 043 y 064-2013-OA-DPCS de la Dirección General de Promoción de la Salud;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y IV, del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; siendo la salud pública responsabilidad primaria del Estado y la responsabilidad en materia de salud individual compartida por el individuo, la sociedad y el Estado;

J. DEL CARMEN

Que, la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las condiciones jurídicas bajo las cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional y declara de interés nacional la labor que realizan los voluntarios en el territorio nacional, en lo referido al servicio social que brindan a la comunidad, en forma altruista y solidaria;

D. CESPEDES M.

Que, con Resolución Ministerial N° 299-2011/MINSA, se aprobó la Directiva Administrativa N° 174-MINSA/DGPS-V.01, "Directiva Administrativa para el Trabajo con el Agente Comunitario de Salud", que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana, en el primer nivel de atención, para el desarrollo de acciones de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, en el marco de las políticas nacionales de salud;

B Ostos V.

Que, la Dirección General de Promoción de la Salud, es el órgano técnico normativo en los procesos relacionados a la promoción de la salud, así como de contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad, conforme a lo previsto en el artículo 60° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-SA;

J. Zavala S.

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Promoción de la Salud, ha propuesto la actualización de la Directiva Administrativa N° 174-MINSA/DGPS-V.01, aprobada con Resolución Ministerial N° 299-2011/MINSA, y ha propuesto en su reemplazo el Documento Técnico: Orientaciones para el Fortalecimiento de la Labor del Agente Comunitario de Salud, que tiene como propósito contribuir con el mejoramiento de la salud biopsicosocial del individuo, familia y comunidad, a través de la acción del Agente Comunitario de Salud como agente de cambio para el logro de la formación de una cultura en salud en la población, mediante la adopción de estilos de vida saludables;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Promoción de la Salud;

Con las visaciones del Director General de la Dirección General de Promoción de la Salud, la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud Pública;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Documento Técnico: Orientaciones para el Fortalecimiento de la Labor del Agente Comunitario de Salud, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Promoción de la Salud, a través de la Dirección de Participación Comunitaria en Salud, la difusión del citado Documento Técnico, así como la evaluación de su implementación a nivel nacional.

Artículo 3°.- Las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud, las Direcciones de Salud o las que haga sus veces, son las responsables de su implementación, supervisión y aplicación, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 299-2011/MINSA, que aprobó la Directiva Administrativa N° 174-MINSA/DGPS-V.01 "Directiva Administrativa para el Trabajo con el Agente Comunitario de Salud".

Artículo 5°.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Ministerial, en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

J. DEL CARMEN

D. CESPEDES M.

B Ostos J.

J. Zavala S.

PERÚ | Ministerio de Salud

Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud

Percy Minaya León
Viceministro de Salud Pública

María Luz Pérez Goycochea
Directora General de Promoción de la Salud

Alberto Huacoto Delgado
Director de Participación Comunitaria en Salud

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1

I. Finalidad 3

II. Objetivos 3

III. Base legal 3

IV. Ámbito de aplicación 5

V. Contenido 5
5.1 Definiciones 5
5.2 Aspectos contextuales del rol del Agente Comunitario de Salud (ACS) 6
5.3 Modalidades de capacitación del Agente Comunitario de Salud (ACS) 9
5.4 Prevención y riesgo 9
5.5 Sostenibilidad 10
5.6 Líneas de acción para el fortalecimiento de la labor del Agente Comunitario de Salud (ACS) 10
5.6.1 Línea de acción 1: Incorporación como ACS 10
5.6.2 Línea de acción 2: Capacitación del ACS 11
5.6.3 Línea de acción 3: Programación y supervisión de Actividades del ACS 16
5.6.4 Línea de acción 4: Calificación y Recalificación de ACS 16
5.6.5 Línea de acción 5: Incentivos y condiciones 19
5.7 La disponibilidad de recursos y la generación de evidencias sobre los ACS 20

VI. Responsabilidades 20
6.1 En el nivel nacional 20
6.2 En el nivel regional 21
6.3 En el nivel local 21

VII. Anexos 22
- Anexo 1
  Capacitación: Competencias, temas y evidencias por escenarios, según campos de capacitación 23
- Anexo 2
  Modelo de carné del Agente Comunitario de Salud 26
- Anexo 3
  Principales materiales bibliográficos de capacitación por roles del Agente Comunitario de Salud y campos de competencia 27
- Anexo 4
  Aspectos a considerar en la visita de supervisión 32
- Anexo 5
  Cronología Normativa de la Labor del Agente Comunitario de Salud 33
- Anexo 6
  Cronología respecto a la Producción Bibliográfica sobre el Agente Comunitario de Salud 34
- Anexo 7
  Ficha de inscripción 35
- Anexo 8
  Ficha de compromiso-Declaración Jurada 36

VIII. Bibliografía 37

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud, en el marco de las Políticas Públicas de Salud viene intensificando las intervenciones en Promoción de la Salud, apoyado por el Agente Comunitario de Salud (ACS), quien realiza una labor altruista y voluntaria, dejando entrever su vocación de servicio a favor de la salud de la población, con la finalidad de formar una cultura de salud, desarrollando estilos de vida saludables para el logro de una mejor calidad de vida a nivel individual, familiar y comunitario.

Es preciso resaltar, que el ACS es un líder elegido y/o reconocido por su comunidad, en ese sentido realiza acciones voluntarias relacionadas con la promoción de la salud y prevención de enfermedades, en coordinación conjunta con el personal de salud e instituciones locales y regionales, ejerciendo la representatividad de su comunidad, por medio del ejercicio de la participación ciudadana, cumpliendo de este modo su rol articulador entre la comunidad y las autoridades.

En este contexto, se ha elaborado este documento técnico dirigido al personal de salud, con el propósito de establecer las orientaciones técnicas que contribuyan al mejoramiento de la labor que efectúa el ACS en beneficio de su comunidad.

Asimismo, se define el rol del ACS, las particularidades de su elección, seguido de las condiciones básicas para la capacitación en sus diversos roles y el desarrollo de procesos de calificación y recalificación del mismo. Finalmente, se establecen los mecanismos de incentivos para alcanzar la sostenibilidad de la labor del ACS.

I. FINALIDAD

Contribuir con el mejoramiento de la salud biopsicosocial del individuo, familia y comunidad, a través de la acción del Agente Comunitario de Salud (ACS), como agente de cambio para el logro de la formación de una cultura en salud en la población, mediante la adopción de estilos de vida saludables.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer orientaciones técnicas para optimizar la contribución del Agente Comunitario de Salud (ACS), en la formación de una cultura de la salud en la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir el rol del ACS y las modalidades de elección/selección del ACS.
- Definir condiciones básicas para la capacitación del ACS en sus diversos roles.
- Definir condiciones básicas para desarrollar procesos de calificación y recalificación del ACS.
- Definir mecanismos de incentivos para lograr la sostenibilidad de la labor del ACS.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificaciones.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado.
- Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Ley N° 29124, Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.

- Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo Nº 017-2008-SA, que aprueba el Reglamento de Ley N° 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.
- Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Resolución Ministerial N° 146-99-SA/DM, que instituye el Día del Agente Comunitario de Salud y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA, que aprueba los "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud".
- Resolución Ministerial N° 457-2005/MINSA, que aprueba el "Programa de Municipios y Comunidades Saludables".
- Resolución Ministerial N° 402-2006-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Programa de Familias y Viviendas Saludables".
- Resolución Ministerial N° 576-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 091-MINSA/DGPS-V.01, "Directiva Administrativa para la implementación de los procedimientos de Identificación Registro y Actualización de la base de datos de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) a nivel nacional.
- Resolución Ministerial N° 720-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú".
- Resolución Ministerial Nº 422-2008/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 133-2008-MINSA/DST-V.01, Directiva Administrativa para el reconocimiento de los Comités de Vigilancia Ciudadana en Salud.
- Resolución Ministerial Nº 702-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Preparando al Agente Comunitario de Salud para el cuidado integral de la salud y nutrición de las gestantes y de las niñas y niños menores de 5 años".
- Resolución Ministerial N° 991-2010/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 168-MINSA/DGPS-V.01, Directiva Administrativa para el Voluntariado en Salud.
- Resolución Ministerial N° 049-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Promoviendo el derecho a la identificación para el ejercicio del derecho a la salud, en el marco del Aseguramiento Universal".
- Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad".
- Resolución Ministerial Nº 889-2012/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Metodología para la Capacitación de las y los Agentes Comunitarios de Salud - Guía de la y el Facilitador".
- Resolución Vice Ministerial N° 539-95-SA-VM, que establece el reconocimiento a la labor abnegada del Agente Comunitario de Salud, por su valiosa colaboración al MINSA.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento Técnico es de aplicación en todos los establecimientos de salud bajo responsabilidad del Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGSS, así como en aquellos pertenecientes a las Direcciones Regionales de Salud - DIRESAs, Gerencias Regionales de Salud - GERESAs, o quienes hag an sus veces.

El presente Documento Técnico podrá ser difundido en los gobiernos locales y a modo de documento de referencia en las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que desarrollan intervenciones con el Agente Comunitario de Salud.

V. CONTENIDO

5.1 DEFINCIONES

- **Agente Comunitario de Salud (ACS)**

  Es la persona elegida y/o reconocida por su comunidad, que realiza acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, en coordinación con el personal de la salud y otras instituciones, locales y regionales, ejerciendo la representatividad de su comunidad a través de la participación ciudadana, cumpliendo de esa manera el rol articulador entre la comunidad y las autoridades.

- **Voluntario en Salud**

  Es la persona que de manera altruista, solidaria y participativa, habiendo pasado un proceso de selección, previa inscripción, es debidamente informado y capacitado en las áreas de su competencia para realizar diversas actividades de servicio, asistencia, soporte, intervenciones en casos de emergencia, labores de campo y comunitarias, brindando su tiempo, experiencia y conocimiento a favor de los beneficiarios y la ciudadanía, en busca del bienestar común, realizando sus actividades de manera desinteresada, en forma gratuita, sin vínculo ni responsabilidad contractual, afán protagónico o de lucro. El voluntario/a de ninguna manera podrá sustituir el trabajo que se realiza en forma remunerada.[1]

- **Promoción de la Salud**

  Busca desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas, familias y comunidades tener mayor control sobre su salud y mejorarla.[2]

  La Promoción de la Salud orienta los esfuerzos hacia el compromiso social para la mejora de la salud colectiva; para ello el involucramiento ciudadano y la articulación de actores sociales son aspectos importantes en el desarrollo de la salud a nivel local.

- **Determinantes Sociales de la Salud (DSS)**

  Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.[3]

[1] Directiva Administrativa para el Voluntariado en Salud, aprobado con Resolución Ministerial N° 991-2010/MINSA.
[2] Lineamientos de Policita de Promoción de la Salud, aprobado con Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA
[3] Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Organización Mundial de la Salud, 2008.

Los ACS mediante el abordaje de los DSS orientan su labor con una perspectiva de análisis del contexto o la realidad local, identificando las inequidades sociales y las causas de la situación de la salud.

- **Modelo de Atención de Salud Basado en Familia y Comunidad**

  El Modelo de Atención Integral propuesto releva el foco de atención en la familia, reconociendo que la familia influye en la salud y en la enfermedad de sus miembros. Asimismo, la situación de salud de cada miembro influye al sistema en su conjunto. Esta relación se expresa en la existencia en la familia de características que pueden ser factores protectores o condiciones de riesgo que hay que identificarlos e intervenirlo desde el nivel operativo en los establecimientos de salud y el nivel político desde el Estado, a nivel nacional, regional y local.[4]

- **Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED).**

  Es un equipo multidisciplinario de trabajadores de salud que mediante la oferta móvil de salud, se desplaza a las localidades consideradas excluidas y dispersas para brindar atención integral en salud de manera complementaria con la red local de servicios de salud.[5]

5.2 ASPECTOS CONTEXTUALES DEL RO L DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD (ACS)

A través de su acción el ACS contribuye a ***generar comportamientos y estilos de vida saludables en la población,*** actuando principalmente en espacios comunitarios y en el escenario familiar; así como también, contribuye al ***desarrollo de entornos saludables*** interactuando principalmente con diversos actores como son las autoridades de nivel local, representantes de instituciones y organizaciones sociales, para darles a conocer sobre la importancia y necesidad de elaborar e implementar programas, proyectos y planes que favorezcan el desarrollo de la salud local.

Otras personas que desarrollan actividades de salud, como las parteras tradicionales podrán ser incluidas como ACS, si cumplen con los criterios del presente Documento Técnico como el reconocimiento formal por su comunidad, para la promoción de comportamientos y estilos de vida saludable, desarrollo de entornos saludables, entre otras actividades.

El ACS es un referente importante de la comunidad para promover comportamientos saludables en la población.

El ACS cumple **diversos roles en su comunidad**, que son reconocidos en la normatividad del Ministerio de Salud - MINSA, entre los que destaca: Ser promotor de la salud[6], orientador, comunicador y educador, opcionalmente articulador, líder, agente de cambio y movilizador social.

Algunos de ellos, van más allá del modelo biomédico y son una respuesta al nuevo escenario en el que hoy debe desenvolverse ACS.

El ACS, no desempeña necesariamente todos esos roles desde el inicio de su actividad; los va asumiendo paulatinamente en tanto sea su opción y expectativa personal. Por esta razón, para comprender y organizar mejor el rol del ACS, se han clasificado en tres niveles acumulativos:

[4] Documento Técnico: Modelo de atención integral basado en familia y comunidad, aprobado con Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA.

[5] Norma Técnica de Salud de los Equipos de Atención de Salud a poblaciones excluidas y dispersas, aprobado con Resolución Ministerial N° 478-2009/MINSA.

[6] Se refiere a aquella persona que promociona la salud, no confundir con la anterior denominación del ACS.

ACS		
	Nivel Básico :	Rol de Educador Sanitario
	Nivel Intermedio :	Rol de Supervisor – Capacitador
	Nivel Avanzado :	Rol de Gestor Comunal

a) Nivel Básico: Educador Sanitario

Este es el rol básico de todo ACS y el primero que desempeña al concluir su capacitación inicial. Lo desarrolla en el escenario comunitario y familiar, en una relación con grupos de personas (vasos de leche, comedores, instituciones educativas, etc.) o de persona a persona. Gracias a la capacitación inicial recibida y a la actualización de conocimientos que recibirá en el proceso de capacitación continua, desarrollará actividades de promoción de comportamientos saludables en la población, según etapas de vida y otras de naturaleza preventiva.

Adicionalmente, deberá tener conocimientos básicos de primeros auxilios, también sobre identificación de riesgos y de cómo referir al establecimiento de salud. Por lo general, empezará centrando su atención en la problemática de la salud materno-perinatal y la desnutrición infantil, para luego abordar la prevención de problemas sanitarios en otras etapas de vida.

Asimismo, apoyará las campañas de salud que se organicen a nivel de la comunidad, así como el funcionamiento de los centros de vigilancia comunitaria y la vigilancia epidemiológica y nutricional en la comunidad.

Realizará actividades de promoción de la salud en el escenario familiar, cuando se detecten criterios de riesgo sanitario debidamente tipificado por el personal de salud. Entre las acciones para este fin se encuentran el desarrollo de sesiones demostrativas y educativas, visitas domiciliarias y orientación a la población.

Este rol de Educador Sanitario, es el que debe desempeñar el ACS durante el tiempo que se dedique a este servicio comunitario. Algunos de ellos, que posean las habilidades necesarias y que deseen asumir nuevos roles y responsabilidades podrán optar voluntariamente por asumir responsabilidades en los otros niveles de ACS, siempre que los servicios de salud y la comunidad lo consideren posible y necesario.

b) Nivel Intermedio: Supervisor - Capacitador

A medida, que va desempeñando su rol de Educador Sanitario, el ACS va generando experiencia y seguridad en sí mismo, conociendo más a su comunidad, acumulando nuevos conocimientos técnicos y organizativos, y se va haciendo más visible en el escenario comunal y logrando más importancia en él. Si cuenta con las habilidades necesarias y si desea asumir responsabilidades a este nivel, el ACS recibirá capacitación y entrenamiento adicionales en dichos procesos para realizar funciones de supervisor, capacitador y coordinador de los otros ACS en el rol de Educador Sanitario.

Entre los conocimientos básicos que debe tener, está lo relacionado con la situación de salud de su comunidad proponiendo a la autoridad sanitaria estrategias de intervención.

Sus principales actividades son las de supervisar y capacitar, dada su experiencia y previa profundización de sus conocimientos producto de la capacitación, en técnicas educativas, así como supervisar y acompañar a los otros ACS.

Si bien durante su desempeño como Educador Sanitario (Nivel Básico), habrá realizado alguna de estas actividades, el verdadero tránsito de un rol a otro, se dará cuando en el proceso de **recalificación** (que más adelante se describe), se acuerda entre los servicios de salud, la comunidad y el ACS, y a propuesta de cualquiera de ellos; dar este paso, el cual se ratificará con la firma de un Acta de compromiso individual, donde el ACS manifiesta su interés de asumir estas nuevas responsabilidades.

En la actualidad, en muchos lugares del país hay ACS que están realizando este tipo de actividades, en su comunidad y a la vez capacitan a otros ACS. El proceso de recalificación ha de reconocer este hecho, formalizar en cada caso el rol que desempeña cada Agente Comunitario de Salud y proporcionarle el apoyo de capacitación, asesoría y otros, necesario para que se desempeñe eficientemente.

c) Nivel Avanzado: Gestor Comunal

El Agente Comunitario de Salud, además de desarrollar los roles antes mencionados, podrá realizar otros para enfrentar algunos problemas vinculados a otros determinantes sociales de la salud.

Para ello, es necesario tener habilidades y herramientas necesarias para relacionarse con actores sociales con capacidad de decisión sobre la gestión de dichos determinantes sociales de la salud, como autoridades de los gobiernos locales distritales, provinciales y regionales, funcionarios de programas sociales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de empresas, directivos de otras comunidades y otras asociaciones de ACS, y otros. Además, condiciones favorables como voluntad y decisión política local, medio ambiente saludable, existencia de programas sociales, participación ciudadana, entre otras, que contribuyan a favorecer la salud de las personas.

A este nivel, el ACS debe actuar más en un rol de promotor de desarrollo comunal, para lo cual debe desarrollar un perfil de liderazgo con conocimiento de incidencia política y negociación social, entre otras habilidades personales.

Al igual que en el tránsito del rol de Educador Sanitario al de Supervisor–Capacitador, para que el ACS sea reconocido y apoyado formalmente como Gestor Comunal, será necesario que en el proceso de recalificación se tome dicho acuerdo entre los servicios, la comunidad y el propio ACS, y que se ratifique con la firma de una nueva Acta de compromiso individual para asumir estas actividades.

Los roles de Supervisor - Capacitador y el de Gestor Comunal, no son obligatorios, es decir, cada ACS según sus expectativas y opciones personales decidirá progresar en los tres niveles o quedarse en alguno de ellos.

Asimismo, no todos tienen las condiciones apropiadas (tiempo, conocimiento del tema, interés, entre otros) que les permita asumir las exigencias que traen consigo cada una de estas responsabilidades.

El Gráfico N° 01, da una idea de la dedicación del ACS a los diversos roles según su predominio y de acuerdo a los compromisos contraídos con su comunidad y los servicios de salud.

Gráfico N° 01
"Roles del Agente Comunitario de Salud"



Fuente: DGPS/MINSA.2014

5.3 MODALIDADES DE CAPACITACIÓN D EL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

a) Capacitación Básica Inicial, es la calificación para desempeñarse como Educadores Sanitarios en los campos individual, familiar, comunal, y en los entornos comunitarios. A partir de esta capacitación puede ser reconocido formalmente como ACS.

b) Capacitación continua, es el proceso de actualización permanente de la capacitación de los ACS como educadores sanitarios, que les permite mantener su vigencia en atención a la necesidad de nuevos conocimientos derivados de los cambios en los perfiles epidemiológicos, de las prioridades nacionales, regionales y locales; así como de las demandas de la comunidad. Los procesos de capacitación forman parte de esta modalidad para aquellos que pasen a desempeñar los roles de Supervisor–Capacitador y Gestor Comunal, los cuales como ya se ha dicho, son niveles opcionales para el ACS.

Las características del proceso de capacitación y formalización del ACS serán descritas en el Programa de Capacitación Integral que elaborará la DGPS.

5.4 PREVENCIÓN Y RIESGO

El modelo de "historia natural de la enfermedad", que considera una fase pre patogénica, otra patogénica y una tercera fase que es el resultado, se distingue entre prevención primaria (reducir los factores de riesgo), secundaria (detener el progreso de los procesos patológicos), y terciaria (limitar o reducir las secuelas). De acuerdo, a esta clasificación, el ACS intervendría sobre todo en la promoción de la salud y la prevención primaria y contribuiría en casos excepcionales (brotes, desastres naturales, entre otros.) en acciones de prevención secundaria.

Es conocido que un sistema de salud es más eficaz en la medida que enfatice la prevención en vez de la curación. Sin embargo, el paradigma vigente de nuestro sistema de salud se orienta principalmente a la atención del individuo y a su curación, lo que se refleja en la demanda de la mayor parte de la población.

En tal sentido, resulta oportuno enfatizar y evidenciar acciones realizadas por el ACS, y que la población las tome como ejemplo, para que puedan adoptar comportamientos y practicas saludables.

5.5 SOSTENIBILIDAD

Actualmente, el entorno en el que actúa el ACS ha cambiado, ya no es el mismo de hace 50 años. Además se ha reducido el número de personas que aceptan la responsabilidad de desempeñarse como ACS, dado su carácter voluntario.

Esta situación, se presenta a nivel mundial y es estudiado por instituciones internacionales que investigan qué factores predisponen a que el ACS abandone su actividad y qué animarían a otras personas a asumirla. Éstos pueden clasificarse en tres factores: desarrollo personal, identidad/reconocimiento y compensación material.

- **Desarrollo Personal,** se ponen en práctica a través de las actividades de capacitación y acompañamiento **(Líneas de Acción 2 y 3).**
- **Identidad/reconocimiento,** se ponen en práctica en los procesos de reconocimiento y los de incentivos y condiciones **(Líneas de Acción 4 y 5).**
- **Compensación Material,** en los procesos de incorporación, de incentivos y condiciones **(Líneas de Acción 1 y 5).**

Estos factores, dependiendo como sean abordados, pueden tener consecuencias positivas en el ACS, por ejemplo favorece el compromiso y refuerza la identidad del ACS y su compromiso de servicio, cuando existe un buen trato o el reconocimiento público por parte de los trabajadores de salud.

5.6 LÍNEAS DE ACCION PARA EL FORTALECIMENTO DE LA LABOR DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD (ACS)

5.6.1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: INCORPORACIÓN COMO ACS

Cuando se requiere incorporar al sistema una o un ACS, se utilizan diversos procedimientos organizacionales que se originan desde la comunidad o fuera de ella.

En algunos casos es **elegido por la comunidad**, y en otros **seleccionados** por la entidad capacitadora, aquella que capacita a ACS, que puede ser algunas Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), o por el Establecimiento de Salud con el que coordinan sus actividades[7]. El personal de salud apoyará a la comunidad en el proceso de elección o selección según sea el caso, siguiendo las formalidades que acostumbre a emplear la propia comunidad. Por ejemplo: en una reunión o asamblea comunal.

Si la incorporación, se hubiera hecho por cualquier otro procedimiento distinto de la elección o la selección, se buscará el reconocimiento formal de ésta porque la eficacia de la labor del ACS depende en gran medida de la vinculación con su comunidad. Se tendrá en cuenta formalizar su incorporación como ACS a través de un documento, por ejemplo el Acta de la comunidad, donde se respalda y da legitimidad al ACS.

Es necesario, tomar en cuenta los siguientes aspectos del **perfil** de la persona que sea elegido/seleccionado como ACS:

- Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
- Ser residente de la localidad, como mínimo dos años.

[7] Referencia proporcionada por numerosos promotores de diversas regiones del país asistentes al taller nacional "Análisis de los procesos de participación ciudadana en salud" del 31/01/2013, y al taller de validación de esta propuesta llevado a cabo el 17/05/2013, organizados ambos por la DGPS del MINSA.

- Decisión personal y voluntaria para desarrollar acciones a favor de la salud local.

Una vez nominado el ACS, el establecimiento de salud a cuyo ámbito pertenece, procederá a su registro mediante una ficha de inscripción (Anexo 7) en la que se anotarán todos sus datos, el cual incluirá la Ficha de Compromiso – Declaración Jurada (Anexo 8) mediante el cual se compromete al cumplimiento del rol para el que fue elegido o seleccionado.

El plazo de ese compromiso tiene un límite mínimo de **dos años** (salvo caso de fuerza mayor) y un máximo indefinido. No se fija un límite máximo, pues mientras el ACS desempeñe adecuadamente su labor (de lo que dará cuenta el proceso de capacitación) podrá continuar desempeñándola si lo desea. Si en algún momento, deseará dejar de realizar las actividades de ACS, bastará con que lo informe a la comunidad, a los servicios de salud y a su asociación (si la tuviera) por escrito en carta simple.

Si un ACS, no reporta actividades en un periodo de tres meses, aun cuando no hubiera un documento comunicando su retiro, se considerará automáticamente como inactivo o retirado, lo que se anotará en su ficha de inscripción.

Del reingreso a la función: Si algún ACS hubiera dejado de serlo por más de un año (no ha sido capacitado, ni ha realizado actividades durante ese periodo), su reincorporación será como si se tratase de un nuevo ACS.

5.6.2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: CAPACITACIÓN DEL ACS

El ACS no llega a serlo por la simple elección, selección e inscripción, es necesario que adquiera conocimientos y habilidades que permitan el óptimo desarrollo de sus actividades comunales.

Una vez elegida o seleccionada e inscrita la persona, debe pasar por un proceso de capacitación, conforme a las pautas establecidas en el "Programa de Capacitación Integral del ACS". Una vez capacitado el ACS, la Red de Salud lo incluirá en el Registro de ACS de su jurisdicción y le entregará los documentos de identificación necesarios, con conocimiento de la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, informando de ello al gobierno local respectivo.

La capacitación del ACS deberá estar a cargo de la DIRESA/GERES A/DISA o la que haga sus veces, lo que se realizará de acuerdo al Programa de Capacitación Integral del ACS.

Para responder a la complejidad generada por el nuevo escenario demográfico y epidemiológico en el que deben desenvolverse hoy los ACS y dar unidad a sus procesos de capacitación y desarrollo de actividades, se plantea un esquema básico de capacitación que siendo acumulativo permite que a lo largo del tiempo vayan desarrollando nuevas capacidades. Este esquema propone desarrollar habilidades de la siguiente manera:

A. CAMPOS DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS

Nivel Básico: Educador Sanitario (Promotor de Salud)

Prevención del Riesgo y la Enfermedad

En las comunidades aún se relaciona la salud con la ausencia de enfermedad, por ello plantean exigencias de este tipo al ACS, la comunidad prioriza las acciones curativas y demanda este tipo de atenciones, por lo que el ACS debe tener conocimientos mínimos sobre prevención de riesgos y enfermedades más frecuentes en sus comunidades, conocer lo

básico de primeros auxilios; permitiendo orientar a la población en esas circunstancias.

Sin embargo, es básico que conozcan sus limitaciones para el tratamiento y manejo de un paciente enfermo y que sepan derivar o referir los casos a tiempo, aún si sólo se trata de sospecha, para que sean diagnosticados y tratados en los diversos niveles de atención de la Red de Salud. Igualmente tienen que conocer algunos síntomas o signos de las enfermedades de notificación obligatoria, apoyar y fortalecer el sistema de vigilancia comunal sobre la sospecha de enfermedades o situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.

Promoción de la Salud

Conocer la importancia de los estilos de vida y los entornos, y su relación con la salud, es fundamental. El ACS debe conocer la importancia de los determinantes sociales de la salud, en la forma cómo viven las personas y las familias y sobre las situaciones que les afectan en su salud.

Debe conocer cómo la salud es el resultado de la interacción de aspectos sociales, ambientales, biológicos, organizacionales, y que a la vez se ven influenciados por los determinantes sociales, abordaje de los determinantes sociales así como la importancia de los entornos saludables (familia, comunidades, instituciones educativas, centros laborales, universidades, entre otros).

Con algunos ejemplos debe poder inducir y capacitar a la población, líderes y organizaciones sociales, en cómo intervenir en la comunidad a través de la promoción de la salud. Asimismo, debe conocer y aplicar nuevas herramientas para trabajar con grupos organizados, instituciones del sector público y privado, para lo cual debe desarrollar habilidades para coordinar y concertar con los actores identificados.

Nivel Intermedio: Supervisor-Capacitador

El ACS que opte por incrementar sus funciones a un segundo nivel, deberá ser capacitado para desarrollar nuevas habilidades para la coordinación y capacitación de otros ACS, y la supervisión de sus funciones, para lo cual es importante que manejen instrumentos básicos o elementales de técnicas educativas, monitoreo, supervisión y evaluación, entre otros.

Nivel Avanzado: Gestor Comunal

Desarrollo Comunal

Para la afirmación del ACS al interior de la comunidad, debe contar con los conocimientos y herramientas que le permitan en representación de su comunidad para incidir en quienes toman decisiones. Por ello, debe estar capacitado para reconocer la importancia de la organización comunal que actúe como núcleo de desarrollo de la comunidad. Para apoyar ese desarrollo, es necesario que sepa planificarlo en base a un diagnóstico previo, que le permita plasmar sus ideas de cambio en un plan de intervención simplificado y entendible, para lo que debe manejar información básica de su comunidad que le permita ver avances, estancamientos o retrocesos, de modo, que se asegure la continuidad del esfuerzo, comprometiendo la participación de la población no sólo como receptores de beneficios, sino como corresponsables de su desarrollo.

Desarrollo Personal e Institucional

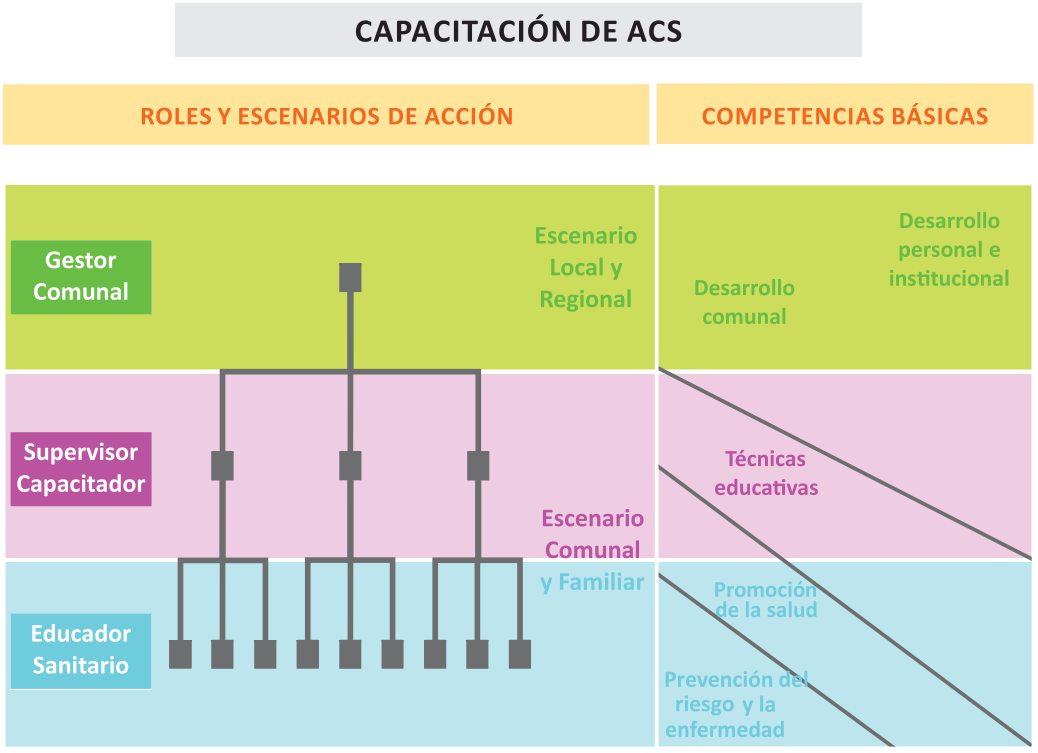
El ACS en su rol de líder social, debe recibir una capacitación que desarrolle las siguientes habilidades:

Comunicación asertiva, conocimientos básicos en abogacía, incidencia política, negociación social y liderazgo; entre otras habilidades que le permitan concertar al interior de su comunidad sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, es decir la construcción de entornos saludables. Asimismo, deben cumplir un rol en representación de la comunidad en el fortalecimiento, trascendencia y sostenibilidad para lo que deben lograr un soporte social de su comunidad e instituciones.

El ACS recibe capacitación para el desempeño de sus diferentes roles. Ésta se dará en forma progresiva y la importancia asignada a las diversas habilidades a alcanzar, irá variando dentro de ese proceso. Estará concentrada, primero en las habilidades referidas a la prevención, que son las predominantes para el rol de Educador Sanitario y progresivamente se irá intensificando la atención al desarrollo de habilidades en promoción de la salud y desarrollo social.

Esta dinámica se ilustra con el Gráfico N° 02, en el que se presentan los roles, sus principales escenarios y el cambio en la atención a los tipos de habilidades por desarrollar (Cuadro N°01).

Gráfico N° 02
"Roles y Competencias del ACS"



Fuente: DGPS/MINSA.2014

Cuadro N° 01
"Niveles y habilidades del Agente Comunitario de Salud"

Competencias a desarrollar	ROLES DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD		
	EDUCADOR SANITARIO (NIVEL I)	SUPERVISOR – CAPACITADOR (NIVEL II)	GESTOR COMUNAL (NIVEL III)
Prevención del riesgo y la enfermedad	Maneja cuidados básicos por etapa de vida promoviendo comportamientos y estilos de vida saludable en la familia. Promueve la identificación de casos en riesgo, derivándolos al EE.SS. de la referencia correspondiente y presta adecuadamente primeros auxilios. Apoya el funcionamiento de los centros de vigilancia nutricional. Apoya el desarrollo de campañas de salud, contribuyendo al logro de sus objetivos.	Promueve acciones básicas de vigilancia epidemiológica y nutricional en la comunidad. Promueve el desarrollo de acciones básicas de prevención y reducción del riesgo de desastres en el ámbito de la comunidad.	Recoge y organiza información sobre la situación de salud y saneamiento en el ámbito de su comunidad. Coordina con los programas sociales y los relacionados con la nutrición infantil, salud materna y otros de prioridad.
Promoción de la Salud	Conoce el concepto de salud y sus determinantes así como las prioridades sanitarias. Conoce el concepto promoción de la salud e identifica algunas estrategias de desarrollo. Conoce y apoya a los Programas de Familias y Viviendas Saludables y colabora con el Programa de Municipios Saludables.	Promueve la participación ciudadana en salud. (Identifica casos que vulneran los derechos de los usuarios en salud). Promueve alternativas de solución a partir de la identificación de necesidades de salud de la familia y comunidad.	Conoce los lineamientos de Promoción de Salud, Modelo de Abordaje y sus ejes temáticos.
Capacitación supervisión	Aplica un conjunto de métodos e instrumentos de comunicación para el cumplimiento de su rol de consejería familiar.	Comprende el papel transformador de la educación en la mejora de la salud de las personas, las familias y comunidad. Conoce la metodología de educación de adultos. Utiliza herramientas básicas de educación de adultos para capacitar y acompañar a otros ACS. Utiliza instrumentos básicos de gestión de una organización y programación de actividades de los ACS.	Conoce el Plan de Desarrollo Comunal Distrital y las agendas de las instituciones privadas y públicas del distrito.
Desarrollo comunal			Participa y estimula la participación y organización comunal (CODECO, JVC, SIVICO u otros similares) Analiza a nivel básico la situación socioeconómica de las familias y la comunidad. Cuenta con habilidades básicas para el monitoreo y evaluación del Plan Comunal; así como para la preparación de proyectos para el presupuesto participativo.
Desarrollo Personal e Institucional			Cuenta con habilidades básicas de liderazgo y solución de conflictos, así como para la coordinación interinstitucional y concertación a nivel distrital y provincial.

Fuente: DGPS/MINSA.2014

El detalle de los temas de capacitación y las evidencias a observar para saber en qué medida se ha desarrollado la habilidad esperada en cada uno de los campos de capacitación se puede ver en el Anexo N° 1 del presente Documento Técnico.

Para desarrollar los temas de capacitación, se cuenta con diversos materiales bibliográficos, construidos sobre experiencias sólidas y validadas en diversos momentos por grupos de Agentes Comunitarios de Salud e instituciones que trabajan con ellos.

En el Anexo 6 del presente Documento Técnico, se adjunta una relación de los principales materiales bibliográficos de capacitación a los que se hace referencia. A modo de ejemplo, en el Anexo 3, se consigna una sugerencia de materiales bibliográficos que tratan los temas de capacitación indicados. Sin embargo, se recomienda emplear de preferencia materiales educativos elaborados regionalmente y cuyos contenidos tengan vigencia de acuerdo con las prioridades regionales/locales, el perfil epidemiológico y las necesidades de la comunidad.

La capacitación se hará empleando metodología de educación de adultos, con el apoyo de especialistas y desde una perspectiva intercultural, lo que implica vincularse con los agentes de la medicina tradicional y otros que desarrollen dicha actividad.

La capacitación del ACS, la han venido realizando diferentes instituciones (iglesias, ONG, Agencias de Cooperación y el propio sector) en todo el país, aplicando temáticas y metodologías diferentes; lo que hace necesario sistematizarlo y estandarizarlo. A partir del cual el Ministerio de Salud a través de la DGPS, debe elaborar el Programa de Capacitación Integral del ACS, lo que complementaria el presente Documento Técnico.

B. PASANTÍAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Una modalidad muy importante de capacitación, que a la vez actúa como un reforzamiento del compromiso del ACS, es la pasantía en comunidades y el intercambio de experiencias de la labor del ACS en el nivel local.

El encuentro entre ACS de distintas localidades (cercanas o lejanas) bajo cualquiera de las dos modalidades (pasantía e intercambio de experiencia), dinamiza su actuar. Es necesario organizar de manera sistemática estas actividades, identificar las experiencias que deben ser conocidas y las facilidades que existen para realizar las pasantías o las visitas de intercambio a través de un programa, coordinado entre la DIRESAS/GERESAS/DISA S o la que haga sus veces y el Ministerio de Salud. De igual modo, será necesario gestionar recursos que financien dichas actividades, lo que involucrará a diferentes entidades públicas y buscará alianzas en el sector privado.

C. LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

La capacitación del ACS no generará las consecuencias esperadas en la comunidad, si el personal de salud con el que coordinará para realizar sus actividades no comprende la importancia de su rol, como ocurre en la mayoría de los casos; es necesario que las DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, desarrollen sistemáticamente estas capacidades en su personal, lo que permitirá mejorar el clima organizacional con relación al ejercicio del rol de los ACS.

5.6.3 LÍNEA DE ACCIÓN 3: PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL ACS

La capacitación del ACS no termina con el desarrollo de los contenidos de los módulos de la fase presencial. Continúa con la programación de actividades y supervisión de los mismos, y esta tarea será de responsabilidad compartida, concertada y coordinada, entre el personal de los establecimientos, los ACS supervisores-capacitadores y de las DIRESAS/ GERESAS/DISAS o la que haga sus veces.

La supervisión es una acción de capacitación en servicio. En ella, se da asistencia técnica al ACS en aquellos aspectos de su rol, en los que presentan debilidades. Los responsables asumirán una actitud de empatía, de diálogo y asesoría con los ACS que visitan, evitando las actitudes sancionadoras. Las visitas no pueden ser inopinadas y las fechas deben ser coordinadas con los ACS. Los ACS con más experiencia que han aceptado comprometerse con el rol de Supervisor–Capacitador, realizarán las visitas de acompañamiento según la sectorización del establecimiento de salud[8], bajo la coordinación y dirección de la Red de Salud.

La programación de actividades que realizará el ACS en la jurisdicción asignada deberá ser elaborada por cada establecimiento de salud del primer nivel de atención en coordinación con sus ACS.

En la medida, en que se comprometa el apoyo de los gobiernos regionales y locales a la labor de los ACS, dicho plan de trabajo será también presentado a estas instancias.

La programación de actividades es una herramienta importante del cumplimiento de las actividades que realizará el ACS. Antes de efectuar la visita de supervisión, el responsable del establecimiento revisará dicha programación para iniciar el acompañamiento.

En la visita de supervisión, se recogerá la información mediante una encuesta respecto al grado de satisfacción de quienes reciben las acciones del ACS, ya sea en forma individual o colectiva. Concluida la visita, se elaborará un informe que incluirá recomendaciones a los servicios de salud. Para ello, se aplicará una matriz de supervisión (Ver Anexo 4 del presente Documento Técnico).

Los Agentes Comunitarios de Salud nuevos en la función, recibirán no menos de tres visitas de acompañamiento en el primer año. Los de mayor trayectoria recibirán no menos de una visita al año.

5.6.4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: CALIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN DEL ACS

Un programa básico de capacitación es la manera de unificar la actuación de los agentes comunitarios de salud a nivel nacional. Éste debe complementarse con un procedimiento de calificación y recalificación para garantizar la calidad de su desempeño.

La calificación da cuenta de la calidad de la capacitación inicial recibida y de que con ella los agentes comunitarios de salud están expeditos para el cumplimiento de sus roles y funciones en su comunidad como Educador Sanitario.

La recalificación da cuenta de que habiendo concluido la etapa de capacitación inicial, los agentes comunitarios actualizan periódicamente sus conocimientos y realizan sus actividades de acuerdo a su programación al servicio de sus comunidades. Mientras la calificación da cuenta solamente de cómo ha asimilado el ACS la capacitación recibida, la recalificación da cuenta de cómo asimila la

[8] Sectorización de comunidades asignada al personal de salud.

capacitación recibida y si está prestando sus servicios a la comunidad de acuerdo al compromiso contraído.

A. CALIFICACIÓN

Es el reconocimiento formal, que hace la autoridad de salud regional o local a los Agentes Comunitarios de Salud por la capacitación inicial recibida y concluida satisfactoriamente (ver criterios en Cuadro 2).

Será otorgada por la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, sobre la base del informe de la Red de Salud. Asimismo, recibirá el informe aprobatorio de la entidad responsable de la capacitación de los ACS.

Siendo la capacitación progresiva, mediante módulos, la conclusión satisfactoria de cada módulo ameritará una constancia y la conclusión del conjunto de módulos, la calificación.

Los criterios para otorgar las constancias y la calificación son los siguientes:

Cuadro N° 02

Criterios para la calificación

CONSTANCIAS	FUENTES DE VERIFICACIÓN
Más de 80% de asistencia a la capacitación presencial	Registro de asistencia a la capacitación.
Más de 75% de logros de aprendizaje en la capacitación presencial.	Pruebas objetivas y registros de evaluación.
Reconocimiento del cumplimiento de su programa de prácticas del curso de ACS en su comunidad.	Registros de monitoreo y acompañamiento de la institución responsable de capacitación.
CALIFICACIÓN	**FUENTES DE VERIFICACIÓN**
Aprobación de todos los módulos de capacitación	Constancias

Fuente: DGPS/MINSA. 2104

Concluido el proceso de calificación, la Red de Salud otorgará al ACS una constancia (diploma con foto) que atestigua su condición de ACS de su jurisdicción, además del respectivo carné (ver ejemplo en Anexo 2).

B. RECALIFICACIÓN

Es el reconocimiento formal que hace la DIRESA/GERESA/DISA a lo s ACS sobre la actualización de sus conocimientos y el desarrollo de actividades a favor de la comunidad.

Igual que para la calificación, será otorgada por la DIRESA/GER ESA/DISA o las que haga sus veces previo informe de la Red de Salud correspondiente sobre la base del informe de cada EE.SS (producc ión).

Será periódica, en plazos que se establecerán regionalmente, recomendándose que sea cada dos años, y sobre esta base se otorgarán los nuevos carnés por el período que se haya establecido.

Los criterios para otorgar la recalificación son los siguientes:

RECALIFICACIÓN	FUENTES DE VERIFICACIÓN
Aprobación de todos los módulos de actualización en cada evaluación anual.	Constancias de capacitación.
Ejecución del más del 80% de las actividades de su programación anual (se basa en las actividades reportadas).	Informe de actividades ejecutadas.

Los establecimientos de salud llevarán un registro de los ACS calificados y recalificados de su jurisdicción, información que compartirán con la Red de Salud, DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, MINSA, Geren cia de Desarrollo Social del gobierno regional y gobiernos locales correspondientes.

Hay dos procesos importantes a poner en marcha para la recalificación: el informe de actividades y la evaluación de conocimientos de los ACS.

B.1 INFORME DE ACTIVIDADES (PRODUCCIÓN)

Consiste en el reporte de las actividades que realizan los ACS. Esta información debe ser procesada por cada establecimiento de salud, a través de quienes administran la programación de actividades de los ACS, y luego lo remitirán a su Red de Salud.

Será preciso capacitar a los Agentes Comunitarios de Salud para el adecuado registro de sus actividades, en los instrumentos definidos para tal fin por la DIRESA/GERESA/DISA. Esto permitirá individualiza r y medir la producción individual de cada ACS. Para mantener un sistema de información activo, la Dirección General de Promoción de la Salud - DGPS tendrá que coordinar con la Oficina General de Estadística e Informática-OGEI y a nivel de Red y Micro Redes, los establecimientos de sa lud tendrán que analizar con los ACS la información recogida y adec actividades a los resultados de ese análisis.

El flujo que debe seguir la información se presenta en el Gráfico N° 03:

Gráfico N° 03
Flujo de información sobre las actividades de los ACS



Fuente: DGPS/MINSA.2014

Los reportes de los ACS se registrarán en el archivo que cada uno de ellos tiene en la Red de Salud.

B.2 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La labor de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS), se evaluará en un evento colectivo que se realizará específicamente para ese fin, por lo menos una vez al año y comprenderá a los Agentes Comunitarios de Salud que se encuentran registrados en las Redes de Salud correspondientes. Esta tarea será de responsabilidad compartida, concertada y coordinada entre la Red de Salud, el personal de los establecimientos de salud y representantes de las comunidades y de los gobiernos locales en donde fuera posible.

Cada DIRESA/GERESA/DISA organiza rá el proceso general de evaluación de los ACS y realizará la convocatoria en su jurisdicción, para lo cual conformará un comité Ad hoc el que se encargará de las coordinaciones con las Redes de Salud y elaborará la prueba escrita.

Las Redes de Salud, se encargarán de la ejecución de la evaluación de acuerdo a lo indicado por el Comité Ad hoc Regional, así mismo se hará cargo de la calificación de las pruebas y el envío de los resultados consolidados al nivel regional.

Los ACS que obtengan una nota aprobatoria estarán listos para continuar el proceso de calificación o recalificación según corresponda. En caso que no obtengan una nota aprobatoria, podrán dar otra prueba dentro de los siguientes treinta (30) días, de acuerdo a lo que indique la Red de Salud y de continuar en la misma condición, deberán entrar en un programa especial de capacitación y reforzamiento dentro de los siguientes treinta (30) días de aplicada la segunda prueba, luego del cual se procederá a una tercera y última evaluación escrita, la cual de continuar desaprobada no le dará derecho a la calificación o recalificación.

5.6.5 LÍNEA DE ACCIÓN 5: INCENTIVOS Y CONDICIONES

La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, propiciarán meca nismos concertados con el gobierno regional y/o local, la comunidad organizada, así como con otros actores sociales, para crear las condiciones e incentivos que permitan que los ACS se mantengan en su labor voluntaria de servicio a la comunidad.

Estos mecanismos de incentivos estarán orientados al reconocimiento de la labor de los Agentes Comunitarios de Salud, tanto formales (constancias de capacitación; reconocimiento y mención en ceremonias públicas por parte del sistema de salud y de la comunidad o del gobierno local; entrega de diplomas y cartas de felicitación), como funcionales (involucrarlos en planificar y evaluar actividades con la comunidad, procesar la información que entregan, darles atención prioritaria cuando lo soliciten en los establecimientos de salud, celebrar con ellos el día del Agente Comunitario de Salud o festividadescomo la navidad, el día de la madre o padre, día del voluntario, entre otras).

Asimismo, para realizar su labor, los Agentes Comunitarios de Salud necesitan de un equipamiento mínimo, tal como indumentaria (mandiles, canguros, chalecos, casacas, y otros.), útiles (mochila, maletín, agenda, entre otros.), equipos e insumos. Las DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus vec es, coordinarán con el gobierno regional y/o local para equipar a los ACS. Este equipamiento ha de servir a la vez como señal de identidad con la que los Agentes Comunitarios de Salud hacen visible su condición a los miembros de la comunidad.

Un factor muy importante a tener en cuenta, es que se debe evitar que los Agentes Comunitarios de Salud, además de realizar voluntariamente su labor para servir a su comunidad, tengan que aportar también sus propios recursos para solventar los gastos que trae consigo realizar ese rol. Por ejemplo, el costo de su desplazamiento o de su alimentación cuando deben acudir fuera de su comunidad a apoyar en campañas o a participar en actividades de capacitación. Es responsabilidad de las DIRESA/GERESA/DISA, o las que hagan s us veces, gestionar los recursos para que se cubran los gastos que hacen los Agentes Comunitarios de Salud para desempeñar sus actividades operativas.

Las DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, dispondrán de los recursos necesarios para atender a los ACS en los casos que lo requieran y, en la medida de lo posible, implementarán un chequeo anual de su estado de salud.

La gestión de recursos para potenciar la labor de los ACS es responsabilidad de las DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces. Para ello, la c oordinación con los gobiernos regionales y locales, con los programas sociales activos en la jurisdicción y el diseño de proyectos de apoyo, y cualquier otro mecanismo de que busque promover, beneficiar o incentivar el ejercicio del rol del ACS debe ser un tema de atención permanente.

5.7 LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS SOBRE LOS ACS

Sin contar con evidencias sobre el efecto de la labor de los ACS, es sumamente difícil obtener recursos para sostener y potenciar su labor. La búsqueda de esas evidencias por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud - OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNIC EF, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID y otros, es muy intensa en los últimos años y la necesidad de contar con ellas en nuestro país es fundamental.

Para generar estas evidencias será importante contar con el apoyo del Instituto Nacional de Salud – (INS), para promover investigaciones sobre la efectividad de la intervención con ACS sobre la salud comunitaria. La Dirección General de Promoción de la Salud - DGPS coordinará con las instancias corr espondientes, para contar con las evidencias necesarias.

VI. RESPONSABILIDADES

6.1 EN EL NIVEL NACIONAL

- El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud - DGPS mantendrá un repositorio digital actualizado de los materi ales de capacitación existentes y hacerlo llegar a las DIRESA/GERESA/DI SA o la que haga sus veces, para que a su vez lo entreguen a las Redes de Salud.
- El Ministerio de Salud a través de la DGPS es responsable de d ifundir, supervisar, brindar asistencia técnica, monitorear y evaluar, lo establecido en este Documento Técnico.
- La implementación del presente Documento Técnico se realizará de manera paulatina. Esto implica concentrar la atención en algunas DIRESAS/GERESAS/DISAS o la que haga sus veces, que ya se encuen tran trabajando eficientemente con los ACS.
- El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud - (DGPS) orientará la construcción de una línea de base con ACS, as í como los ACS capacitados. Se recogerá también información sobre las características de la

capacitación recibida y el tipo de actividades que se encuentran realizando, también sobre cuántos de los ACS capacitados se encuentran activos y cuántos han dejado de estarlo (calificación y recalificación).

6.2 EN EL NIVEL REGIONAL

- La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, son responsables de desarrollar en el ámbito de su jurisdicción, procesos similares a los que pondrá en marcha a nivel nacional la DGPS, en relación con lo que se establece en este Documento Técnico. Esto implica que la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, será responsable en primer lugar de la coordinación con el Gobierno Regional de acciones necesarias para que la labor de los ACS se articule con los organismos correspondientes, dentro de las gerencias de desarrollo social; y en segundo lugar, coordinar con los gobiernos locales (provinciales y distritales) las acciones que evidencien la importancia de contar con ACS en su territorio y las posibles formas de apoyar su capacitación y el desarrollo de sus actividades.
- La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, presentará propuestas a través de planes o proyectos para implementar, sostener o mejorar la labor del ACS, ante el gobierno regional y/o local según corresponda. Dichos planes o proyectos se incluirán en los planes institucionales y serán recogidos de las propuestas de Redes y Micro redes.
- La DIRESA/GERESA/DISA o las que haga sus veces, son responsables de concertar y coordinar la participación de los actores sociales en la implementación de esta propuesta, con aportes diversos de las instituciones (agencias de cooperación, iglesias, gobiernos regionales y locales, ONG) que capacitan y contribuyen al sostenimiento de la labor de los ACS, y son igualmente responsables de garantizar la capacitación del personal de salud del ámbito de sus jurisdicción involucrado en las diversas etapas de trabajo con los ACS.
- La DIRESA/GERESA/DISA o las que haga sus veces, deberán solicitar a la autoridad correspondiente la apertura de presupuestos para el trabajo a desarrollarse con los ACS, incorporándolos en sus planes institucionales, buscando el financiamiento y recursos para las actividades que coordina e impulsa, gestionarán ante las gerencias de desarrollo social de sus propios gobiernos regionales y locales, y ante otros actores del sector público; así como de la sociedad civil de su jurisdicción, la asignación de recursos financieros para los procesos de capacitación y equipamiento de los ACS en sus ámbitos de intervención, para el adecuado desarrollo de sus actividades. De igual modo, la entrega de incentivos para optimizar la labor de los ACS en la promoción de la salud en los espacios comunal y local.
- La DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, dará a conocer, implementará, cumplirá y hará cumplir lo especificado en este Documento Técnico, debiendo compartir la información con la Gerencia Social de su Gobierno Regional y a la Dirección General de Promoción de la Salud - DGPS del Ministerio de Salud.

6.3 EN EL NIVEL LOCAL

- Las jefaturas de las Redes/Micro redes y los Establecimientos de Salud (EE.SS.), conjuntamente con el encargado de promoción de la salud de la jurisdicción en la comunidad y el jefe del equipo AISPED [9] (comunidad intervenida) cuando corresponda, del primer nivel de atención, son responsables de la ejecución de las acciones orientadas al fortalecimiento de la labor de los Agentes Comunitarios de

[9] Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED).

Salud, en el marco del proceso de implementación de políticas nacionales, regionales y locales u otras prioridades sanitarias.

- Las Micro redes y EE.SS. deberán informar mensualmente a la Red de Salud a la que pertenecen respecto a las actividades realizadas para fortalecer la labor de los ACS. Además, en coordinación con el gobierno local, contribuirá n a difundir y brindar las facilidades para la implementación en su ámbito de lo propuesto en este Documento Técnico.
- La Red de Salud remitirá a la DIRESA/GERESA/DISA o la que haga sus veces, la información mensual proveniente de las Micro redes sobre la producción de actividades de los ACS, así como la relación actualizada de los ACS en los periodos que corresponde, según lo establecido en el presente Documento Técnico.
- La Red de Salud, procurará el desarrollo de las actividades operativas de los ACS, así como de proporcionar el soporte logístico para ello. Los responsables de promoción de la salud de la Red serán los encargados de la coordinación e involucramiento de las diversas instancias y direcciones en la implementación, monitoreo y evaluación de la aplicación de lo propuesto en este Documento Técnico a nivel del ámbito de la Red de Salud, la que deberá reportar e informar trimestralmente a la DIRESA/GERE SA/DISA o la que haga sus veces.
- La Red de Salud, Micro redes y EE.SS, reportarán e informarán trimestralmente a la DIRESA/GERESA/DISA la información relacionada a los ACS esta blecido en el presente Documento Técnico para lo cual diseñarán los instrumentos de recolección de información para la línea de base, así como otros necesarios para el trabajo con los ACS.
- El personal de salud del establecimiento de salud, deberá de identificar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo de su trabajo con el agente comunitario de salud.

VII. ANEXOS

- Anexo 1 Capacitación: Competencias, temas y evidencias por escenarios, según campos de capacitación
- Anexo 2 Modelo de carné del ACS
- Anexo 3 Principales materiales de capacitación por roles del Agente Comunitario de Salud y campos de competencia
- Anexo 4 Aspectos a considerar en la visita de supervisión
- Anexo 5 Cronología Normativa de la Labor del Agente Comunitario de Salud
- Anexo 6 Cronología respecto a la Producción Bibliográfica sobre el Agente Comunitario de Salud
- Anexo 7 Ficha de inscripción
- Anexo 8: Ficha de compromiso-Declaración Jurada

ANEXO 1:
CAPACITACIÓN: COMPETENCIAS, TEMAS Y EVIDENCIAS POR ESCENARIOS, SEGÚN CAMPOS DE CAPACITACIÓN

1.- PREVENCIÓN DEL RIESGO Y LA ENFERMEDAD			
Entorno	**Competencias**	**Temas de capacitación**	**Evidencia**
1. Individuo, familia y comunidad	1.1 Promueve estilos de vida saludables por etapa de vida, mediante el desarrollo de sesiones educativas y demostrativas.	1.1.1 Cuidados del niño/niña menores de 5 años. 1.1.2 Cuidados del niño/niña de 5 a 11 años. 1.1.3 Estilos de vida en adolescentes. 1.1.4 Estilos de vida en jóvenes. 1.1.5 Estilos de vida del adulto. 1.1.6 Estilos de vida del adulto mayor.	Conocimiento teórico de la norma nacional adecuada y simplificada. Observación de procedimiento.
	1.2 Presta adecuadamente primeros auxilios.	1.2.1 Atención de heridas, quemaduras y traumatismos. 1.2.2 Atención de urgencias comunes. 1.2.3 Detección de intoxicaciones y envenenamientos. 1.2.4 Bioseguridad.	Conocimiento de la Guía de Primeros Auxilios. Observación de manejo simulado de casos.
	1.3 Promueve y apoya la participación en campañas de salud.	1.3.1 En qué consiste una campaña de salud. 1.3.2 La importancia de la participación de la comunidad. 1.3.3 Manejo de información de resultados de campañas.	Elabora un plan ficticio de apoyo a una campaña de salud en la comunidad.
	1.4 Promueve el funcionamiento de los centros de vigilancia nutricional.	1.4.1 Causas de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y anemia. 1.4.2 Cómo se hace la vigilancia nutricional comunal. 1.4.3 Manejo de instrumentos de vigilancia nutricional.	Conoce causas directas e indirectas de la DCI y anemia. Maneja instrumentos de vigilancia nutricional.
	1.5 Promueve y apoya la vigilancia epidemiológica en la comunidad en casos de brotes y epidemias.	1.5.1 Enfermedades de vigilancia y control nutricional. 1.5.2 Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunal I, metodología e instrumentos.	Enumera 5 enfermedades de notificación obligatoria. Muestra registro de notificación de casos.
	1.6Promueve y apoya la prevención y reducción de riesgo en el ámbito de la comunidad.	1.6.1 Estimación del riesgo de desastres y posibles causas de desastres en el ámbito comunal y cómo evitarlos. 1.6.2 Funciones de Defensa Civil en caso de desastre. 1.6.3 Acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres.	Grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres. Mapa de riesgos de desastres. Planes de prevención y reducción de riesgos, conoce causas de desastres en ámbito comunal. Maneja mapa de riesgos de desastres en el ámbito comunal.
2. Escenarios sociales (II.EE., centro laboral, universidades, entre otros).	2.1 Recoge y organiza la información sobre la situación de salud y saneamiento.	2.1.1 Sistema de información comunal. 2.1.2 Cómo implementar un sistema de información comunal con datos básicos en salud.	Elabora un sistema de información comunal con datos reales de su comunidad.
	2.2 Identifica casos que vulneran los derechos de los usuarios en salud.	2.2.1 Deberes y derechos de usuarios en salud.	Identifica las necesidades de la población y reconoce las atenciones/actividades que ofrece el EE.SS.
	2.3 Coordina con los programas sociales y los relacionados con la nutrición infantil.	2.3.1 Principales programas sociales. 2.3.2 Estructura de los programas en la comunidad y criterios de coordinación de acciones.	Conoce el programa JUNTOS, SIS, Qali Warma, Cuna Más. Conoce la Junta Directiva de JUNTOS en su comunidad.

2.- PROMOCIÓN DE LA SALUD			
Entorno	**Competencias**	**Temas de capacitación**	**Evidencia**
1. Individuo, familia y comunidad.	1.1 Conoce los determinantes sociales de la salud. 1.2 Desarrolla habilidades para el trabajo con personas, familias y comunidad.	1.1.1 ¿Qué es un determinante social?. 1.1.2 Principales determinantes en su ámbito. 1.2.1 Técnicas de educación de adultos, para educar e informar a personas, familia y comunidad. 1.2.2 ¿Cómo hacer una visita domiciliaria, cómo registrarla y cómo hacer el monitoreo?.	Enumera por lo menos tres determinantes sociales de la salud de su ámbito. Observación de una visita familiar simulada. Informe de monitoreo y evaluación (fichas).
2. Comunidad	2.1 Identifica necesidades de salud de la comunidad.	2.1.1 ¿Cómo hacer un diagnóstico comunal participativo?.	Enumera los pasos para elaborar un diagnóstico comunal.
	2.2 Identifica alternativas de solución o de atención de necesidades de salud comunales.	2.2.1 ¿Cómo hacer un plan comunal participativo?. 2.2.2 ¿Cómo implementar, monitorear y evaluar un plan participativo?.	Enumera los pasos para elaborar un plan comunal participativo. Enumera los pasos de la implementación, monitoreo y evaluación.
3. Escenarios sociales (I.E, Centro laboral, Universidades, entre otros).	2.3 Conoce los lineamientos de Promoción de la Salud del MINSA.	2.3.1 Lineamientos de Promoción de Salud del MINSA y su aplicación en la región. 2.3.2 Lineamientos de salud regionales.	Enumera los lineamentos de Promoción de la Salud del MINSA. Enumera los lineamientos de salud de la Región.
	2.4 Conoce el Plan de Desarrollo Comunal Distrital y las agendas de las instituciones privadas y públicas del distrito.	2.4.1 Plan de Desarrollo Concertado (PDC) distrital aspectos básicos. 2.4.2 Agendas de las instituciones privadas y públicas del distrito.	Explica los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de su distrito. Conoce plan de acción de una ONG o institución importante de la zona.
	2.5 Colabora con el Programa de Familia Saludable.	2.5.1 Programa de Familia Saludable. 2.5.2 Modelo de Atención Integral Basado en Familia y Comunidad (MAIBFC).	Conoce el Programa de Familia Saludable.

	3.- SUPERVISIÓN - CAPACITACIÓN		
1. Familia			
2. Comunidad	2.1 Conoce metodología de educación de adultos.	2.1.1 Metodología de educación de adultos, teoría y práctica.	Conoce bases de educación de adultos. Demuestra cómo educar a un adulto.
	2.2 Desarrolla habilidades para capacitar y acompañar a otros ACS.	2.2.1 Plan de capacitación del ACS de la red. 2.2.2 Instrumentos educativos.	Conoce y explica el plan de capacitación de la asociación de ACS de su zona.
	2.3 Conoce instrumentos básicos de gestión de una organización.	2.3.1 Importancia de la organización de los ACS a nivel distrital o provincial. 2.3.2 Plan de ACS y rol del ACS.	Explica la importancia de contar con una asociación de ACS. Explica el plan de acción de la asociación de ACS.
	2.4 Desarrolla habilidades para promover la buena gestión de la asociación de ACS.	2.4.1 ¿Cómo promover la organización de los ACS?. 2.4.2 ¿Cómo medir y mejorar la gestión de asociación de ACS?.	Conoce indicadores para evaluar el plan de la asociación de ACS.
3. Entorno Social			

4.- DESARROLLO COMUNAL (GESTOR COMUNAL)			
Entorno	**Competencias**	**Temas de capacitación**	**Evidencia**
1. Familia			
2. Comunidad	2.1 Participa y estimula la participación y la organización comunal: Comité de Desarrollo Comunal (CODECO), Junta Vecinal Comunal (JVC), Sistema de Vigilancia Comunal (SIVICO, o equivalente).	2.1.1 Funciones del CODECO, JVC o equivalente y su rol en el desarrollo comunal.	Conoce el plan comunal y cronograma de reuniones comunales del CODECO o JVC.
	2.2 Analiza la situación socioeconómica de las familias y la situación productiva o de mercado en la comunidad.	2.2.1 Elaboración de material educativo para involucrar a familias y autoridades en diagnóstico y plan comunal.	Muestra información comunal en aspecto económico, salud y educación.
	2.3 Desarrolla habilidades para el monitoreo y evaluación del plan comunal.	2.3.1 Identificación de indicadores de evaluación y periodos de evaluación del plan.	Elabora indicadores de medición del cambio y la mejora en la comunidad.
3. Entorno Social			

5.- DESARROLLO PERSONAL E INSTITUCIONAL (GESTOR COMUNAL)			
Entorno	**Competencias**	**Temas de capacitación**	**Evidencia**
1. Familia			
2. Comunidad			
3. Entorno social e Institucional	3.1 Desarrolla habilidades de liderazgo, concertación y solución de conflictos.	3.1.1 Actitudes del líder comunal. 3.1.2 Formas y maneras de comunicación.	Caracteriza aspectos positivos de un líder. Establece nuevas formas de comunicación con terceros.
	3.2 Coordina con líderes, autoridades y dirigentes del nivel distrital y provincial.	3.2.1 Herramientas para coordinar y concertar.	Elabora un plan para una reunión comunal útil.
	3.3 Colabora en la preparación de proyectos para el presupuesto participativo.	3.3.1 Procesos de presupuesto participativo. 3.3.2 Importancia de los proyectos comunales.	Describe las fases del proceso de presupuesto participativo anual de su distrito. Conoce lo que es un proyecto social.
	3.4 Desarrolla habilidades para relacionar la asociación de ACS con otras asociaciones o instituciones.	3.4.1 ¿Cómo trabajar con otras asociaciones de ACS y actuar coordinadamente?. 3.4.2 ¿Cómo relacionar la asociación de ACS con otras asociaciones o instituciones?.	Elabora un plan de articulación entre las asociaciones de ACS con instituciones o con otras asociaciones de ACS.

ANEXO 2

MODELO DE CARNÉ DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

Elementos básicos en un carné de Agente Comunitario de Salud

PERÚ Ministerio de Salud

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Dirección Regional de Salud

CARNÉ DE AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

Nombres y Apellidos: .....

DNI:..... **Dirección:** .....

.....

Sector:..... **Microred:**.....

Establecimiento:.....

Fecha de Vigencia: .....

Sr (a).....

Presidente (a)

Fecha de Emisión .....

ANEXO 3:

PRINCIPALES MATERIALES BIBLIOGRAFICOS DE CAPACITACION POR ROLES DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD Y CAMPOS DE COMPETENCIA

ROLES	Prevención del riesgo y la enfermedad	Promoción de la Salud	Supervisión y capacitación	Desarrollo comunal	Desarrollo personal e institucional
ACS I Educador Sanitario	▪ **OMS.** El Agente de Salud Comunitario 1987. ▪ **APRISABAC.** Capacitación a Promotores de Salud, El Promotor de Salud y la organización de su trabajo 1999. ▪ **PSNB.** Manual del promotor y la promotora 2001. ▪ **PACD-DIRES Ayacucho.** Manual para la capacitación: Promotores de Salud; Primer Nivel Cuidando la Salud de las Personas; Segundo Nivel Cuidando la Salud de la Familia 2001. ▪ **OPS-CIDA.** Manual del Agente Comunitario de Salud Factores Protectores Medidas Preventivas 2001. ▪ **CARE.** Manual 3 Salud Reproductiva, 4 Planificación Familiar, 5 Salud Materna y 6 ETS y VIH-SIDA 2002. ▪ **MINSA-DGPS.** Guía de implementación del Programa de Familias y	▪ **OMS.** El Agente de Salud Comunitario 1987. ▪ **APRISABAC** Metodología Para el Trabajo Comunitario en Salud 1999. ▪ **PACD-DIRES.** Ayacucho Manual para la capacitación: Promotores de Salud; Segundo Nivel Cuidando la Salud de la Familia 2001. ▪ **CARE.** Manual 2 Participación Comunitaria y 7 Derechos y responsabilidades en salud 2002. ▪ **MINSA-DGPS.** Guía de implementación del Programa de Familias y Viviendas Saludables 2005. ▪ **ADRA-MINSA-Antamina.** Manual Implementación Familias y Viviendas Saludables 2008. ▪ **PROANDES-MINSA-UNICEF.** El Botiquín Comunal 2008. ▪ **MINSA-DGPS.** Documento Técnico: Preparando al ACS para el cuidado integral de la			

ROLES	Prevención del riesgo y la enfermedad	Promoción de la Salud	Supervisión y capacitación	Desarrollo comunal	Desarrollo personal e institucional
	Viviendas Saludables 2005. ▪ **ADRA-MINSA-Antamina.** Manual Implementación Familias y Viviendas Saludables 2008. ▪ **MINSA-DGPS.** Documento Técnico: Preparando al ACS para el cuidado integral de la salud y nutrición de las gestantes de las niñas y niños menores de 5 años "El Manual del ACS" 2009. ▪ **MINSA-DGPS.** Manual de capacitación para el voluntariado en salud 2010. ▪ **ADRA.** Manual de fortalecimiento familiar para ACS 2011. ▪ **UNICEF-WHO.** Manual for the Community Health Worker Caring for the sick child in the community 2011. ▪ **MINSA-DGPS.** Metodología para la capacitación de las y los ACS. Guía de la y el facilitador 2012. ▪ **MMN-Salud Sin Límites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013.	salud y nutrición de las gestantes de las niñas y niños menores de 5 años "El Manual del ACS" 2009. ▪ **Organismo Andino de Salud.** Convenio Hipólito Unánue Sistema de vigilancia Comunitaria en el Perú Criterios para el diseño. ▪ **MINSA-DGPS.** Manual de capacitación para el voluntariado en salud 2010 ▪ **ADRA** Manual de fortalecimiento familiar para ACS 2011. ▪ **MINSA-DGPS.** Metodología para la capacitación de las y los ACS. Guía de la y el facilitador 2012. ▪ **MMN-Salud Sin Límites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013.			

ROLES	Prevención del riesgo y la enfermedad	Promoción de la Salud	Supervisión y capacitación	Desarrollo comunal	Desarrollo personal e institucional
ACS II Supervisor Capacitados			▪ **APRISABAC.** Capacitación a Promotores de Salud, El Promotor de Salud y la organización de su trabajo 1999. ▪ **PSNB.** Manual del promotor y la promotora 2001. ▪ **CARE.** Manual 1 Gestión de programas de capacitación 2001. ▪ **OPS-CIDA.** Manual del Agente Comunitario de Salud Factores Protectores Medidas Preventivas 2001. ▪ **OPS-Cruz Roja USA-NNUU.** 2004 AIEPI Comunitario Guía para facilitadores de la capacitación a agentes comunitarios de salud 2004. ▪ **MINSA-DGPS.** Metodología para la capacitación de las y los ACS. Guía de la y el facilitador 2012. ▪ **MMN- Salud Sin Límites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013. ▪ **PRODES-MASAL-APODER-USAID.** Programa de Formación de Líderes Comunitarios Módulos 1 Identidad, 2 Diagnóstico y Planificación Comunitaria y 3 Manejo de ▪ Conflictos + Guía del Facilitador 2006. Adaptación para directivos e integrantes de CODECO Proyecto ALAC-Yanacocha 2010.		

ROLES	Prevención del riesgo y la enfermedad	Promoción de la Salud	Supervisión y capacitación	Desarrollo comunal	Desarrollo personal e institucional
ACS III Gestor Comunal		▪ **MINSA-DGPS.** Guía Metodológica para la implementación de Municipios Saludables. ▪ **MMN-Salud Sin Límites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013.		▪ **APRISABAC.** Capacitación a Promotores de Salud, El Promotor de Salud y la organización de su trabajo 1999. ▪ **MINSA-DGPS.** Metodología para la capacitación de las y los ACS. Guía de la y el facilitador 2012. ▪ **Organismo Andino de Salud.** Convenio Hipólito Unánue Sistema de vigilancia Comunitaria en el Perú Criterios para el diseño. ▪ **MMN-Salud Sin Límites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013. ▪ **MINSA-DGPS.** Guía Metodológica para la implementación de Municipios Saludables. ▪ **PRODES-MASAL-APODER-USAID.** Programa de Formación de Líderes Comunitarios Módulos 1 Identidad, 2 Diagnóstico y Planificación Comunitaria y 3 Manejo de Conflictos + Guía del	▪ **OMS.** El Agente de Salud Comunitario 1987. ▪ **APRISABAC.** Metodología Para el Trabajo Comunitario en Salud 1999 y Capacitación a Promotores de Salud: el Promotor de Salud y la organización de su trabajo 1999. ▪ **PSNB.** Manual del promotor y la promotora 2001. ▪ **CARE.** Manual 1 Gestión de programas de capacitación 2001 y 7 Derecho y responsabilidades en salud 2002. ▪ **OPS - CIDA.** Manual del Agente Comunitario de Salud Factores Protectores Medidas Preventivas 2001. ▪ **OPS-Cruz Roja USA-NNUU.** 2004 AIEPI Comunitario Guía para facilitadores de la capacitación a agentes comunitarios de salud 2004. ▪ **MINSA-DGPS.** Documento Técnico para e trabajo con ACS 2007.

ROLES	Prevención del riesgo y la enfermedad	Promoción de la Salud	Supervisión y capacitación	Desarrollo comunal	Desarrollo personal e institucional
				Facilitador 2006. Adaptación para directivos e integrantes de CODECO Proyecto ALAC-Yanacocha 2010.	▪ **PROANDES-MINSA-UNICEF .** El Botiquín Comunal 2008. ▪ **OPS.** AIEPI Manual del Agente Comunitario de Salud Manual del Facilitador 2010. ▪ **UNICEF-WHO.** Manual for the Community Health Worker Caring for the sick child in the community 2011. ▪ **MINSA-DGPS.** Metodología para la capacitación de las y los ACS. Guía de la y el facilitador 2012. ▪ **MMN-SaludSinLímites.** Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario 2013.

ANEXO 4:

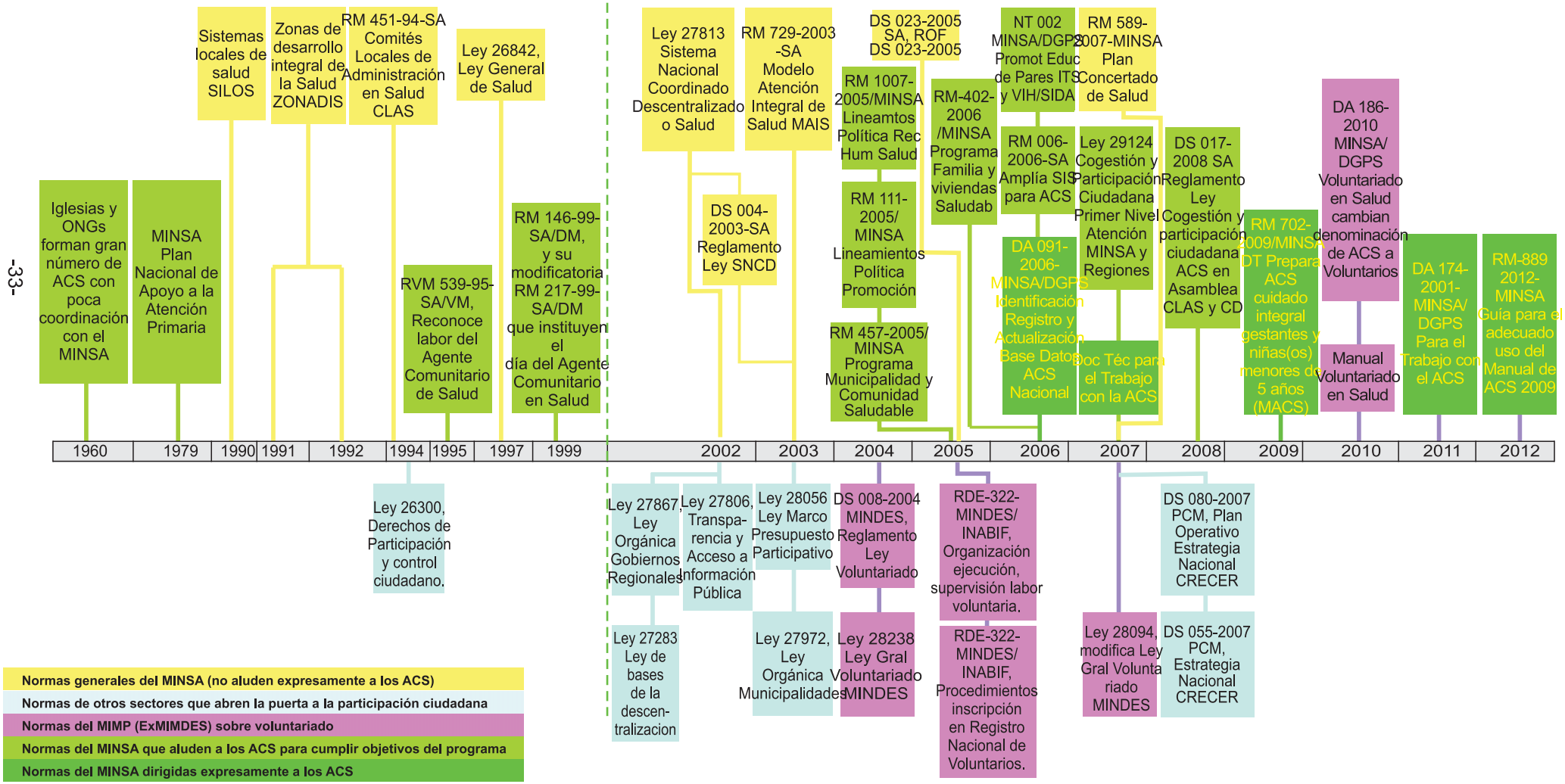
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA VISITA DE SUPERVISION

Puntaje	1. Registro y reporte de actividades	2. Relación con Establecimiento	3. Relación con autoridades de la Comunidad	4. Cumplimiento de Plan de Trabajo	5. Satisfacción de las familias	6. Relación con la Institución Capacitadora
0	No registra ni reporta	No hay relación	No hay relación	No tiene plan	No conocen al ACS	No hay relación
1	Registra y no reporta	Relación esporádica	Relación esporádica	Ejecutó 1/3 del plan	Lo conocen pero no acuden a él	Relación esporádica
2	Registra y reporta a veces	Relación frecuente	Sólo para coordinar actividades	Ejecutó la mitad del plan	No están satisfechos con su labor	Asiste a reuniones capacitación
3	Registra y reporta periódicamente	Permanente contacto	Informa con regularidad	Ejecutó 2/3 o más del plan	Están satisfechas con su labor	Recibe visitas de seguimiento
Actividad de supervisión	Revisión de documentos	Entrevista al responsable de promoción de la salud y/o al Jefe del Establecimiento	Entrevista a alguna autoridad comunal, de preferencia del CODECO o similar	Diálogo con el ACS y revisión de documentos	Entrevista a 3 familias de la comunidad	Entrevista al responsable de ACS de la Institución Capacitadora

7. Problemas del ACS en el desarrollo de actividades	8. Capaci tación del ACS
Qué problemas encuentra	Asiste o no, a sesiones de capacitación
Problemas que encontró y resolvió	Qué aspectos considera necesario reforzar o abordar
Diálogo con el ACS y resumen de lo que informa	Diálogo con el ACS y resumen de lo que informa

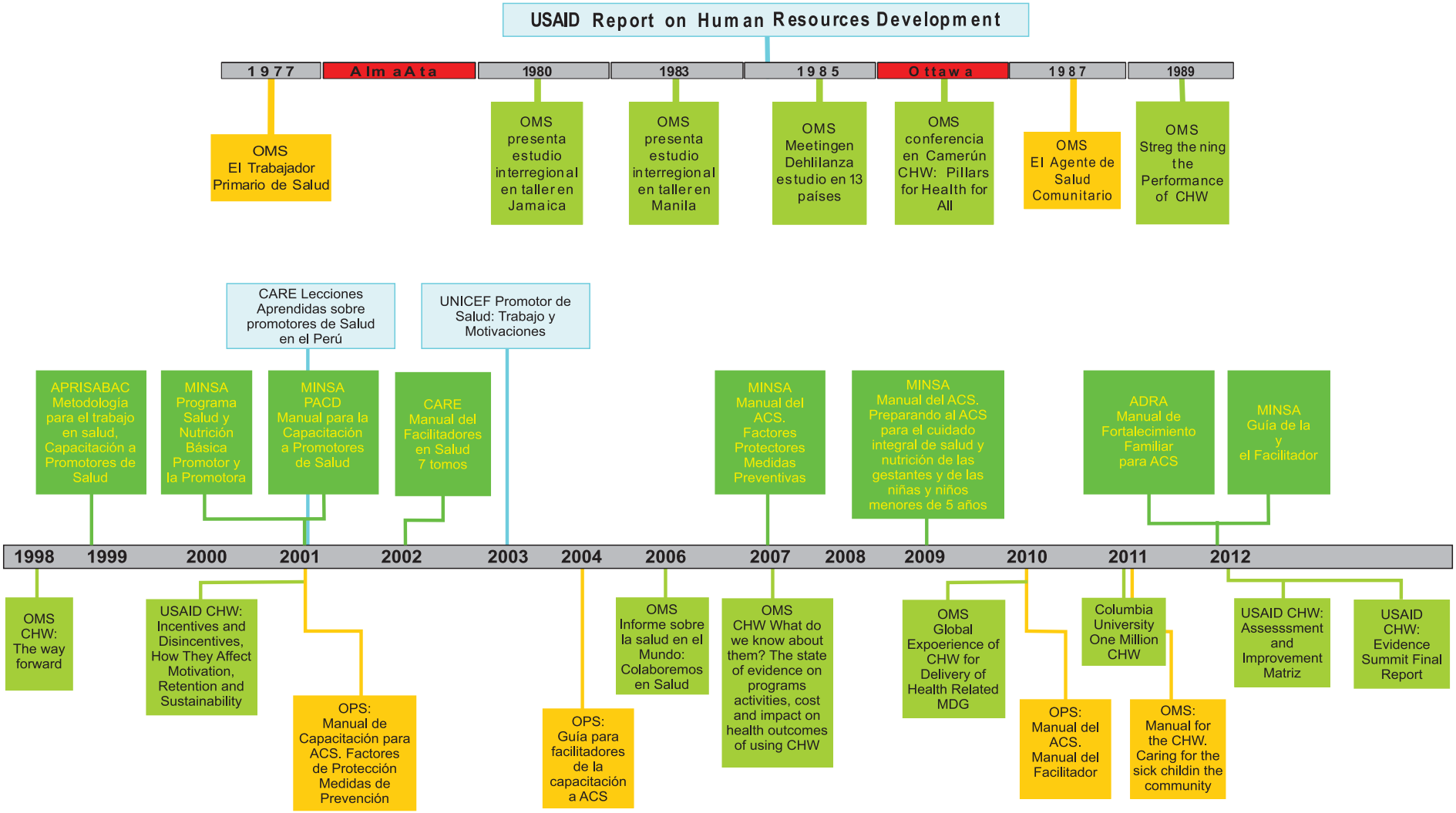
ANEXO 5:

CRONOLOGIA NORMATIVA DE LA LABOR DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD



ANEXO 6:

CRONOLOGIA RESPECTO A LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD



ANEXO 7
FICHA DE INSCRIPCIÓN [10]

En la presente ficha sírvase consignar todos los datos requeridos, marcando con un aspa (X) o complete los espacios en blanco.

1.- DATOS GENERALES

DIRESA					
RED		**MICRO RED**		**EE.SS.**	
PROVINCIA		**DISTRITO**		**COMUNIDAD**	

2. DATOS PERSONALES

Apellido Paterno:	**Apellido Materno:**	**Nombres:**	
Fecha de nacimiento	**DNI**	**SEXO**	**ETNIA**
		F M	
Departamento	**Provincia**	**Distrito**	**Comunidad**
Domicilio actual			
Grado de Instrucción	**Ocupación**	**Idioma/Dialecto que habla**	
SIS/ESSALUD/Otro	**Fecha de inicio de actividades**	**Correo electrónico**	**Teléfono**

Fecha: / / /

[10] Adaptado: Resolución Ministerial N° 576-2006/MINSA y Resolución Ministerial N° 991-2010/MINSA.

ANEXO 8

FICHA DE COMPROMISO-DECLARACIÓN JURADA

Yo……., identificado con Documento de Identidad Nº…… con domicilio real en …… …… … … ……. , distrito, provincia y departamento de ……..., de ocupación …… ……..… ….., en ……

Declaro bajo juramento:

1.- Los datos consignados en mis generales de ley, son verdaderos	☐
2.- No tener Antecedentes Policiales	☐
3.- No tener Antecedentes Judiciales	☐
4.- No tener Antecedentes Penales	☐

Del mismo modo, declaro mi compromiso de actuar con responsabilidad en la labor de Agente Comunitario de Salud y realizar actividades según el rol que corresponde, de manera voluntaria, por un tiempo mínimo de dos años.

……..., …….. de…….. de ……

……

Firma

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. ADRA (2004) Manual de Fortalecimiento Familiar para Agentes Comunitarios de Salud. FFP – USAID Lima, Perú. 40 p.
2. ALTOBELLI L (1994) Evaluación del programa de Promotores de Salud. Ministerio de Salud 1984 Lima, MSH 438 p.
3. ALTOBELLI L, USAID 1984 "Report on Human Resources Development" Ministry of Health, Perú. 265 p.
4. APRISABAC (1999) 2.1 Capacitación a Promotores de Salud. Desarrollo Comunitario Serie 2 Convenio Multilateral Perú-Holanda-Suiza y DIRESA Cajamarca. Cajamarca, Perú. 174 p.
5. APRISABAC (1999) 2.2 Metodología para el Trabajo Comunitario en Salud. Desarrollo Comunitario Serie 2 Convenio Multilateral Perú-Holanda-Suiza y DIRESA Cajamarca. Cajamarca, Perú. 51 p.
6. ARCE M, (2001) Gestión de Programas de Capacitación. Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 1. CARE Perú - MINSA Proyecto Multi sectorial de Población (PMP). Lima, Perú 68 p.
7. ARCE, M (2001) Manual del promotor y la promotora Proyecto Salud y Nutrición Básica MINSA Lima, Perú 345 p.
8. ASKEW I, et al (2012). Community and Formal Health System Support for Enhanced Community Worker Performance Final Report of Evidence Review Team 3 Enhancing Community Health Worker Performance Trough Combining Community and Health System Approaches. USAID A U.S. Government Evidence Summit Washington, DC, USA. 26 p.
9. ASKEW I, et al. (2012) Community and Formal Health System Support for Enhanced Community Worker Performance. Final Report of Evidence Review Team 1 Which Community Support Activities Improve the Performance4 of Community Health Workers?. USAID A U.S. Government Evidence Summit U.S. Government USA. 63 p.
10. ASKEW I. et al. (2012) Community and Formal Health System Support for Enhanced Community Worker Performance. Final Report of Evidence Review Team 2 Which Formal Health System Support Activities Improve the Performance of Community Health Workers? USAID A U.S. Government Evidence S ummit. U. S. Government USA. 30 p.
11. BATTACHARYYA K, WINCH P, LEBAN K, TIEN M. (2001) "Incentives an d Disincentives: How They Affect Motivation, Retention, and Sustainability". Community Health Worker. BASICS ii USAID, Arlington, Virginia. 2001
12. BHUTTA ZA, LASSI ZS, PARIYO G, HUICHO L. (2010) Global Experie nce of Community Health Workers for Delivery of Health Related Millenium Development Goals. A Systematic Review, Country Case Studies, and Recommendations for Integration into National Health Systems" Global Health Worldforce Alliance. WHO-Golbal Worldforce Alliance. Geneva Switzerland. 391 p.
13. CARE-MINSA (2009) Derechos y responsabilidades en salud. CLAS u na oportunidad para ejercerlos Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 7 Guía de Autoaprendizaje. CARE Perú - MINSA Proyecto Multisectorial d e Población (PMP) Programa de Administración de Acuerdos de Gestión. Lima, Perú 130 p.
14. CRIGLER L, HILL K, FURTH R, BJERREGAARD D,(2011) Community Heal th Worker Assessment and Improvement Matrix (CHW AIM): A Toolkit f or Improving CHW Programs and Services. USAID Health Care Improvement Projec t. University Research Co. Bethesda MD. USA. 146 p.
15. DE HABICH M, (2013) Perspectivas y Desafíos de la Reforma del S ector Salud MINSA, Lima Perú (PPT. 14 diapo).

16. EVANS T et al (2006) Informe sobre la Salud en el Mundo 2006 - Colaboremos por la Salud. OMS Ginebra, Suiza, 219 p.
17. KAHSSAY HM, TAYLOR ME, BERMAN PA (1998) Community Health Worker s: the way forward WHO Public Health in Action 4. Geneva, Switzerland. 78 p.
18. LEHMANN U, SANDERS D. (2007) Community Health Workers: what do we know about them? The estate of evidence on programmes, activities, costs and impact on health outcomes of using community health workers. WHO, Evidence and Information Policy, Department of Human Resources for Health. Geneva, Switzerland, 42 p.
19. LUCAS J, (2011) Manual for the Community Health Worker. Caring for the sick child in the community. Integrated Management of Childhood Illness. Caring for the Newborns and Children in the Community. OMS - UNICEF 133 p.
20. MINSA - DIRESA AYACUCHO (2001) Manual para la Capacitación. Pro motores de Salud Primer Nivel. Proyecto de Atención de Salud a Comunidades Dispersas (PACD). Ayacucho, Perú. 77 p.
21. MINSA - DIRESA AYACUCHO (2001) Manual para la Capacitación. Pro motores de Salud Primer Nivel. Proyecto de Atención de Salud a Comunidades Dispersas (PACD). Ayacucho, Perú. 77 p.
22. MINSA (1981) Atención Primaria de Salud en el Perú. COMISION Na cional de Atenci´n Primaria de Salud, MINSA, Lima, 1981 61 p.
23. MINSA (2009) Perú: Línea Basal Metas de RHUS 2007-2015 Observa torio de Recursos Humanos Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos. MINSA Lima, Perú. 18 p.
24. MORÁNA, PICHILINGUEc,GARAYJ,ROQUEL,ROJASM,OVALLEN, CNACHAYA R. (2012) Las educadoras comunales en nutrición y la r educción de la desnutrición crónica. Sistematización de una estrategia exitosa para la reducción de la desnutrición crónica en comunidades rurales dispersas de la Sierra 2007-2011 Ancash Perú; Cáritas del Perú. Lima, Perú. 79 p.
25. MORÁN A, VILLANUEVA C, GARAY J, ROJAS M, CANCHAYAR, (2011) Reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil en Ancash Proyecto Ally Micuy 2007-2010; Cáritas del Perú - Antamina, Lima, Perú. 119 p.
26. NAIMOLI JF, FRYMUS DE, QUAIN E, ROSEMAN EL (2012) Community ad Formal Health System Support for Enhanced Community Worker Performance. Final Report USAID A U.S. Government Evidence Summit U.S. Gover nment USA. 62 p.
27. OMS (1984) Community Health Workers. A report of the World Health Organization Interregional Study and Workshop 4-8 July 1983, Manila, Philippines. Geneva, World Health Organization 1984 (unpublished document SHS/HMD/84.1).
28. OMS (1987) Community Health Workers: Pillars for Health for All. Report of the Interregional Conference. Yaoundé, Cameroon 1-5 December 1986. Geneva. World Health Organización, 1987 (unpublished document SHS/CIH 8 7.2).
29. OMS (1987) The Community Health Worker Working guide. Guidelines for training. Guidelines for adaptation. Geneva, Switzerland. 452.p.
30. OMS (1987) The Community Health Worker Working guide. Guidelines for training. Guidelines for adaptation. Geneva, Switzerland. 452.p.
31. OMS 1980 "Primary Health Care. The Community Health Worker". Report on a UNICEF/WHO Interregional Study and Workshop (Kingston, Jamaica) 1979/1980. Geneva, World Health Organization, 1980 (unpublished document PHC/80.2).
32. OPS (2004) Guía para facilitadores de la capacitación a agentes comunitarios de salud. American Red Cross - United Nations Foundation. Serie OPS/FCH/CA/04 2 (1).E AIEI. Componente comunitario de la estrategia AIEPI Was hington D.C. USA. 46.p.

33. OPS (2010) Manual del Agente Comunitario de Salud. Manual del Facilitador AIEPI Proyecto Curso de Vida Saludable. Área de Salud Familiar y Comunitaria. Serie OPS/FCH/HL/10.10.E Washington D. C. USA. 118.p.
34. OPS. (2012) Resultados de la Primera Medición de las Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud 2007-2015. 5. p
35. PEREYRA H. (2007) Manual del Agente Comunitario de Salud Facto res Protectores Medidas Preventivas MINSA, CIDA ASTM, ADECAP reimp resión OPS-ADECAP Lima, 53 p.
36. PERRYH. (2013) On the Roadin Brazilto Achieving Health for All Trough Primary Health Care Bloomberg, School of Public Health. John Hopkins University (PPT 19 Diapo).
37. RAMOS I (2002) Participación Comunitaria SIVICO. Un modelo para capacitar a Promotores de Salud. Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 2. CARE Perú - MINSA Proyecto Multisectorial de Población (PMP) Lima, P erú 180 p.
38. RAMOS I, ARCE M (2002) Enfermedades de transmisión sexual y VIH /SIDA Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 6. CARE Perú - MIN SA Proyecto Multisectorial de Población (PMP) Lima, Perú 158 p.
39. RAMOS I, BILLINGHURST V, ARCE M (2002) Planificación Familiar Un modelo para capacitar a Promotores de Salud. Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 4. CARE Perú - MINSA Proyecto Multisectorial de Població n (PMP) Lima, Perú 100 p.
40. RAMOS I, BILLINGHURST V, ARCE M (2002) Salud Materna Un modelo para capacitar a Promotores de Salud Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 5. CARE Perú - MINSA Proyecto Multisectorial de Población (PMP) Li ma, Perú 100p.
41. RAMOS I, BILLINGHURST V, ARCE M (2002) Salud Reproductiva. Un m odelo para capacitar a Promotores de Salud. Serie Manual del Facilitador en Salud Módulo 3. CARE Perú - MINSA Proyecto Multisectorial de Població n (PMP) Lima, Perú 188 p.
42. RICSE C, VALLENAS, S, ZÚÑIGA R (2001) Lecciones aprendidas sobr e promotores de salud en el Perú Aportes al Desarrollo Nº1 CARE, Lima, Perú, 8 p.
43. SACO A, (2008) Buscando la Salud. Para consolidar la democracia y superar la pobreza CARE-Programa Derechos en Salud, CIES - Observatorio de la Salud. Instituto Nacional Demócrata Para Asuntos Internacionales (NDI) , Lima, Perú, 162 p.
44. SÁNCHEZ N (2013 (2013) Módulos Capacitación dirigidos a los y las ACS y Consejos de Desarrollo Comunitario MEDICUS MUNDI NAVARRA – SALU D SIN LÍMITES (en impresión)
45. SINGH P, SULLIVAN S (2011) "One Million Community Health Workers", The Earth Institute, Columbia University Technical Task Force Report. New York. USA. 104.p.
46. UNICEF/PERÚ - USAID (2003) PROMOTORES DE SALUD y “Trabajo Motivaciones" BUEN INICIO, Lima, Perú. 142 p.



PERÚ | Ministerio de Salud

Av. Salaverry Nº 801 - Lima 11
www.minsa.gob.pe